

Mortalidad por diabetes 2025 - Análisis Nacional, OOAD Jalisco y Unidades Médicas

1. Introducción

Este reporte presenta un análisis integral de la mortalidad por diabetes en la población derechohabiente del IMSS para el año 2025, con énfasis en tres niveles de agregación: nacional, delegacional (OOAD Jalisco) y unidades médicas de la OOAD Jalisco. El objetivo es proporcionar información epidemiológica útil para la planeación, priorización de intervenciones y seguimiento de la carga de enfermedad por diabetes en los distintos niveles de atención.

2. Datos Estadísticos Clave

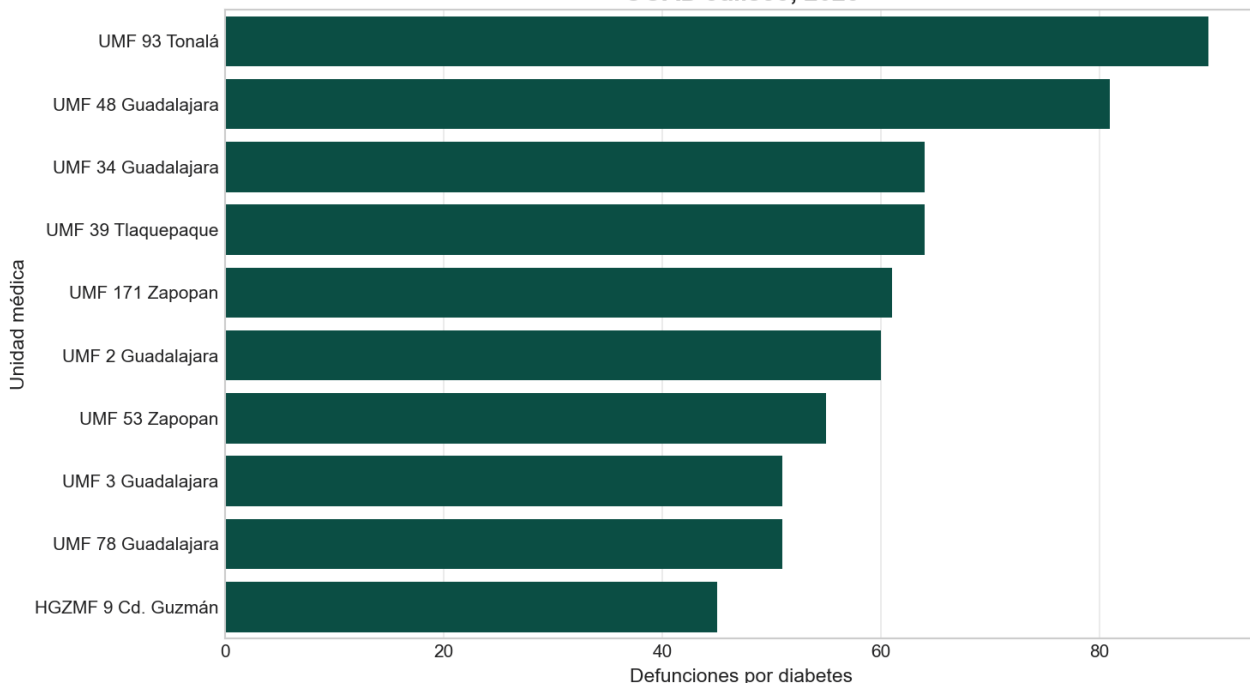
Top 10 unidades por defunciones por diabetes, OOAD Jalisco, 2025

Unidad	Defunciones
UMF 93 Tonalá	90
UMF 48 Guadalajara	81
UMF 34 Guadalajara	64
UMF 39 Tlaquepaque	64
UMF 171 Zapopan	61
UMF 2 Guadalajara	60
UMF 53 Zapopan	55
UMF 3 Guadalajara	51
UMF 78 Guadalajara	51
HGZMF 9 Cd. Guzmán	45

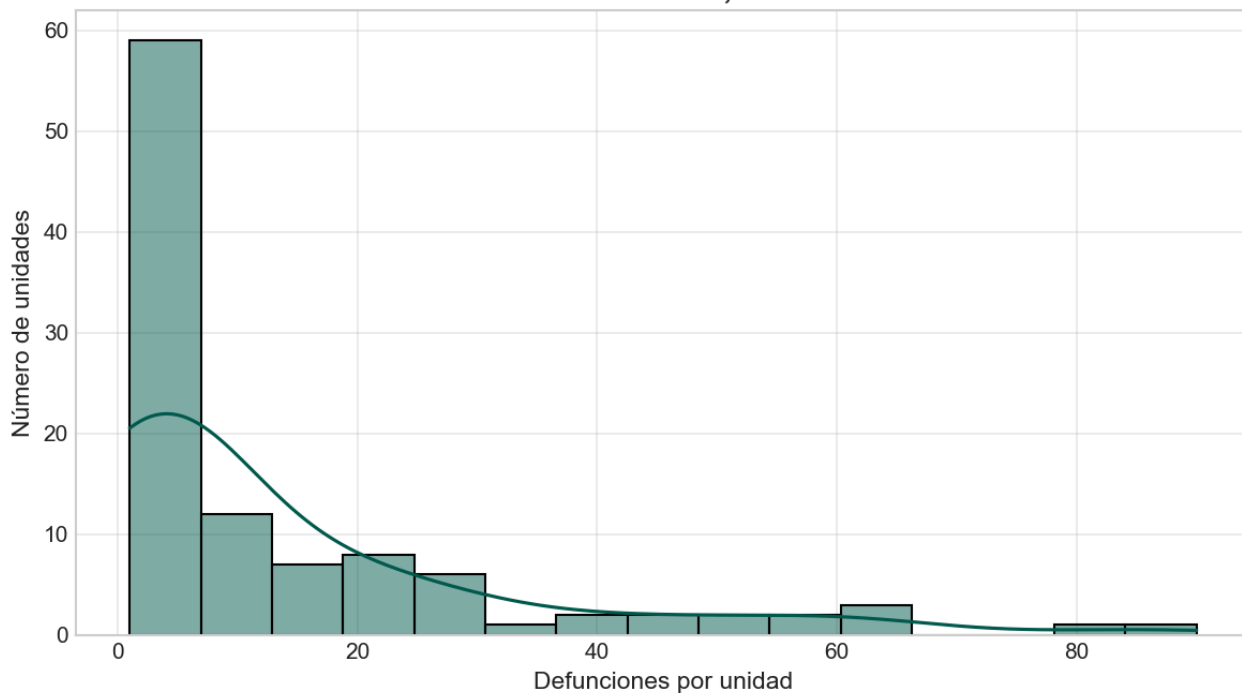
3. Evidencia Gráfica

Mortalidad por diabetes 2025 - Análisis Nacional, OOAD Jalisco y Unidades Médicas

Top 10 unidades por defunciones por diabetes
OOAD Jalisco, 2025



Distribución de defunciones por unidad
OOAD Jalisco, 2025



4. Análisis e Interpretación

1. Panorama nacional 2025\n\nEn el año 2025 se registraron 26,157 defunciones por diabetes a nivel nacional (IMSS),

Mortalidad por diabetes 2025 - Análisis Nacional, OOAD Jalisco y Unidades Médicas

con una tasa de mortalidad de 46.17 defunciones por 100,000 derechohabientes, utilizando como denominador la población adscrita a medicina familiar (56,652,796 personas). Esta cifra refleja la magnitud de la carga de mortalidad atribuible a la diabetes en el Instituto y sirve como referencia para comparar el comportamiento de las distintas OOAD.

La tasa se calculó con la fórmula epidemiológica estándar:

$$\text{Tasa de mortalidad} = \frac{\text{Defunciones por diabetes}}{\text{Población adscrita}} \times 100,000$$

En la OOAD Jalisco se documentaron 1,491 defunciones por diabetes en 2025. Considerando una población adscrita de 4,877,453 derechohabientes, la tasa de mortalidad fue de 30.57 defunciones por 100,000 habitantes, por debajo del promedio nacional (46.17 por 100,000). Esto sugiere que, en términos relativos, la mortalidad por diabetes en Jalisco es menor que la observada en el conjunto del IMSS, aunque el volumen absoluto de defunciones sigue siendo elevado.

3. Distribución por unidades médicas en OOAD Jalisco

Se analizaron 106 unidades médicas de la OOAD Jalisco con al menos una defunción por diabetes en 2025. El número promedio de defunciones por unidad fue de 14.07, con una desviación estándar de 18.84, un mínimo de 1 y un máximo de 90 defunciones. La mediana fue de 5 defunciones por unidad, lo que indica una distribución muy asimétrica, con pocas unidades concentrando un número elevado de defunciones.

El Top 10 de unidades por número de defunciones concentra una proporción importante de la mortalidad delegacional. Destacan:

- UMF 93 Tonalá: 90 defunciones
- UMF 48 Guadalajara: 81 defunciones
- UMF 34 Guadalajara y UMF 39 Tlaquepaque: 64 defunciones cada una
- UMF 171 Zapopan: 61 defunciones

El resto de las unidades del Top 10 (UMF 2 Guadalajara, UMF 53 Zapopan, UMF 3 Guadalajara, UMF 78 Guadalajara y HGZMF 9 Cd. Guzmán) presentan entre 45 y 60 defunciones anuales. Estas unidades representan nodos críticos para la gestión de la atención de pacientes con diabetes, tanto en el primer nivel como en el segundo nivel de atención.

4. Análisis de la distribución de defunciones por unidad

El histograma de defunciones por unidad muestra una distribución sesgada a la derecha: la mayoría de las unidades reportan entre 1 y 20 defunciones anuales, mientras que un subconjunto reducido de unidades concentra valores muy superiores al promedio (hasta 90 defunciones). Esta concentración sugiere la necesidad de revisar tanto la carga de pacientes con diabetes como los procesos de referencia, contrarreferencia y manejo de complicaciones en las unidades de mayor volumen.

La dispersión observada (desviación estándar de 18.84) indica heterogeneidad importante entre unidades, que puede estar relacionada con diferencias en tamaño poblacional adscrito, complejidad de la unidad (UMF vs HGZ/HGZMF), así como variaciones en la calidad de la atención y en la oportunidad de detección y control de la diabetes.

5. Implicaciones operativas y de política

El hecho de que Jalisco presente una tasa de mortalidad por diabetes inferior al promedio nacional es un hallazgo positivo, pero no debe llevar a la complacencia. El volumen absoluto de 1,491 defunciones anuales implica más de 4 defunciones diarias en la OOAD, lo que representa una carga significativa para las familias y el sistema de salud.

Las unidades del Top 10 requieren un análisis más detallado que incorpore información de prevalencia, control metabólico, hospitalizaciones por complicaciones y recursos disponibles (personal, insumos, programas de educación en diabetes). Esto permitirá distinguir si el alto número de defunciones se explica principalmente por el tamaño de la población adscrita o si existen brechas en la calidad de la atención que deban ser abordadas con intervenciones específicas.

Asimismo, la gran cantidad de unidades con pocos eventos anuales obliga a interpretar con cautela las tasas específicas por unidad (cuando se calculen), dado que los números pequeños pueden generar variabilidad aleatoria importante. Para fines de gestión, es recomendable agrupar unidades por tipo y tamaño poblacional para obtener indicadores más estables.

Mortalidad por diabetes 2025 - Análisis Nacional, OOAD Jalisco y Unidades Médicas

5. Conclusiones y Recomendaciones

1. En 2025 se registraron 26,157 defunciones por diabetes en el IMSS, con una tasa nacional de 46.17 por 100,000 derechohabientes, lo que confirma a la diabetes como una de las principales causas de mortalidad en la institución.

2. La OOAD Jalisco aportó 1,491 defunciones (aproximadamente 5.7% del total nacional), con una tasa de 30.57 por 100,000, inferior al promedio nacional, pero con una carga absoluta que sigue siendo elevada.

3. La distribución de defunciones entre las 106 unidades de la OOAD Jalisco es altamente heterogénea: pocas unidades concentran un número muy alto de defunciones (hasta 90), mientras que la mayoría reporta menos de 20 defunciones anuales.

4. Las unidades del Top 10 por defunciones (principalmente UMF de Guadalajara, Zapopan, Tonalá, Tlaquepaque y el HGZMF 9 de Cd. Guzmán) deben considerarse prioritarias para intervenciones de mejora en la atención integral de la diabetes, incluyendo fortalecimiento del primer nivel, seguimiento de pacientes de alto riesgo y coordinación con el segundo nivel.

5. Se recomienda a la OOAD Jalisco: (a) complementar este análisis con información de prevalencia y control de la diabetes por unidad, (b) revisar procesos de atención en las unidades de mayor mortalidad, (c) establecer metas específicas de reducción de mortalidad y (d) monitorear anualmente estos indicadores para evaluar el impacto de las intervenciones implementadas.